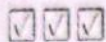
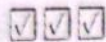


24★★★



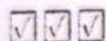
じん肺の管理区分は、粉じん職歴、呼吸困難度、胸部レントゲン分類、呼吸機能検査、動脈血ガス分析の結果などから、管理1～4に分類される。

25★★★



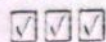
じん肺管理区分の決定は主治医が行う。

26★★★



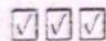
管理2以上の者は、健康管理手帳の交付を申請でき、公費で健康診断を受けられる。

27★★★



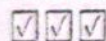
管理4の者、および管理2または3の者で①肺結核、②結核性胸膜炎、③続発性気胸、④続発性気管支炎、⑤続発性気管支拡張症、⑥原発性肺癌のいずれかを合併すると、療養の対象となり労災補償が受けられる。

28★★★



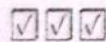
療養の対象になると、療養補償給付として治療費や入院費の給付が受けられる。

29★★★



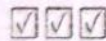
職業曝露以外でアスベスト関連疾患に罹患した場合は、補償制度はない。

30★★★



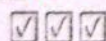
珪肺は全身性のステロイド投与が奏効する。

31★★★



慢性ベリリウム肺はサルコイドーシスに類似した病態を呈する。

32★★★



珪肺ではANCA関連血管炎をきたしやすい。

